

紧密型县域医共体医学检验中心设置标准——官方与权威来源文档检索结果

1. 国家层面政策文件与通用标准

1.1 核心政策框架

1.1.1 《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》 发布机构：国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、农业农村部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局等 10 部门联合印发（国卫基层发〔2023〕41 号），经国务院同意，于 2023 年 12 月 30 日正式发布（来源）（来源）。

该指导意见是当前紧密型县域医共体建设的纲领性文件，为医学检验中心等资源共享中心的建设提供了顶层制度设计。文件在“完善服务功能，提升县域医共体整体服务能力”部分明确提出：“根据成员单位能力基础，统筹建立县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心”，以及肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务中心，“提高资源配置和使用效率，提升服务能力”（来源）（来源）。这一表述将医学检验中心置于五大资源共享中心之首，凸显了其在县域医共体服务体系中的基础性地位。

在管理质量方面，该指导意见要求“统一县域医共体内规章制度和技术规范、人员培训、质量控制等标准，强化县域医共体医疗质量和安全管理”，并特别强调“加强检查检验、疾病诊断质量监测评价”（来源）（来源）。这为医学检验中心的同质化管理和质量控制提供了制度依据。在信息化建设维度，文件提出“统一县域医共体内信息系统，加强数据互通共享和业务协同”，以及“将远程医疗延伸到乡村，推行基层检查、上级诊断、结果互认”（来源），实质上为医学检验中心的远程诊断模式和结果互认机制奠定了政策基础。

该指导意见设定了明确的推进节奏：到 2024 年 6 月底前，以省为单位全面推开紧密型县域医共体建设；到 2025 年底，力争全国 90% 以上的县（市）基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的紧密型县域医共体；到 2027 年底，基本实现全覆盖（来源）（来源）。截至 2025 年 2 月，全国已有 2188 个县推进紧密型县域医共体建设（来源）（来源），医学检验等资源共享中心的建设需求随之急剧扩大。

1.1.2 《紧密型县域医共体信息化功能指引》 发布机构：国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司、国家疾控局综合司联合印发（国卫办规划函〔2025〕63 号），2025 年 2 月 20 日发布，2025 年 3 月 12 日正式对外公布（来源）（来源）。

该功能指引是当前关于县域医共体医学检验中心建设最具操作性的技术性文件，虽然以“信息化功能指引”为名，但实质上构成了医学检验中心建设的核心技术规范。文件将“区域医疗服务协同应用”列为五大功能领域之首，明确包括“医学影像诊断、心电诊断、医学检验、病理诊断、远程会诊、消毒供应、医疗急救等 7 个资源共享中心的信息化功能”（来源）（来源）。

关于医学检验资源共享中心的功能定位，指引作出系统性规定：

维度	具体要求
平台基础	基于全民健康信息平台建设
管理制度	建立统一标准管理制度和质控标准体系
系统定位	医学检验中心实验室管理信息系统（LIS）
核心目标	实现县域内检验数据互联互通，推进结果互认
样本流转	规范采集检验样本，由符合生物安全资质的物流机构冷链集中转运至县级医院医学检验中心检测并出具报告
服务模式	“基层采样、物流转运、中心检测、实时查阅”

这一“分布式检查、集中式诊断”的模式设计，充分考虑了县域医疗体系的现实结构——基层机构承担样本采集、县级医院检验中心承担检测分析、专业化物流承担连接纽带——既保证了检验质量的可控性，又提高了基层医疗机构的服务能力。

指引详细列举了 11 项核心功能模块（来源）（来源）：

序号	功能模块	功能说明
1	检验申请	支持临床医生在线提交检验申请，自动提示采样管类型、颜色等信息
2	样本运输	实现标本从采集点到检测中心的物流跟踪和管理
3	样本核收	支持批量核收、按科室核收等多种方式，记录标本接收状态
4	样本检验	支持手工输入、仪器自动采集等多种结果录入方式
5	结果审核	实行双人审核制度，支持修改痕迹保留和历次结果比对
6	危急值管理	自动识别危急值并启动报告流程，确保及时通知临床
7	报告查询	支持医共体内各成员单位实时查询检验报告
8	报告打印	支持多种格式纸张和打印模板，实现批量打印
9	质控管理	包括质控品设置、质控图绘制、靶值计算等功能
10	统计分析	提供工作量统计、阳性率分析、趋势分析等多维度统计
11	报告模板管理	支持自定义报告格式和模板，实现标准化报告输出

这些功能模块覆盖了检验服务全流程，从临床申请到报告发布，从质量控制到运营管理，形成了完整的功能闭环。特别值得关注的是，“样本运输”和“样本核收”作为独立功能模块被明确提出，凸显了样本物流管理在区域检验体系中的关键地位；“危急值管理”的单独设置则体现了患者安全管理的核心要求。

该指引还提供了江苏省东台市的实践案例。东台市通过建设临床检验中心，实现了“市、区域中心、镇、村全覆盖，配备设备，标本流转规范，结果联网共享，累计服务 64 万人次，减少群众交通费、误工费”[\(来源\)](#)。这一案例表明，标准化的医学检验中心建设能够显著提升服务可及性和群众满意度。

在技术标准遵循方面，指引明确要求系统设计需遵循 ISO 15189、IHE 和 HL7 标准，为居民健康档案系统、区域医疗系统提供良好的临床信息服务[\(来源\)](#)[\(来源\)](#)。同时，硬件设施设备与基础软件应当符合信创要求，应用软件产品符合信创和软件正版化工作要求；网络架构优先依托电子政务外网，按照纵向业务网的要求及紧密型县域医共体的业务特性要求规划网络资源[\(来源\)](#)。

1.2 已发布的相关中心设置标准（参考性文件）

1.2.1 《紧密型县域医共体医学影像中心设置标准》（WS/T 891—2026） 发布机构：国家卫生健康委，2026 年 3 月 17 日发布，2026 年 9 月 1 日正式施行[\(来源\)](#)[\(来源\)](#)[\(来源\)](#)[\(来源\)](#)。

该标准是我国首个针对县域医共体资源共享中心发布的专项设置标准，虽然针对医学影像中心而非医学检验中心，但其标准框架和核心要素对医学检验中心设置标准的制定具有直接的参照价值。标准编号为 WS/T 891—2026，属于推荐性卫生行业标准，备案号 104512-2026，由国家卫生健康标准委员会基层卫生健康标准专业委员会负责技术审查和技术咨询[\(来源\)](#)[\(来源\)](#)。

该标准采用七维度架构体系：

模块	核心内容
基本要求	设置要求（原则上依托牵头医院设置 1 个医学影像中心）、功能要求（集中诊断与报告签发、影像数据管理与共享、远程会诊与协同诊疗、质量控制与管理、教学培训与技术支持）
场所要求	功能区域划分（登记及候诊区、检查区、医务人员办公区、试剂和耗材储存区等）、环境要求（符合 GBZ 130、GB 51039 等标准）
设施设备要求	牵头医院配备 DR 系统、移动式 DR、CT 系统、MRI 系统等；成员单位至少配备常规 DR 系统
人员要求	牵头医院配备不少于 8 名专职医师、5 名专职技师、2 名专/兼职护士；医师中中级职称占比不低于 20%，高级职称占比不低于 10% 且不少于 1 名
信息化要求	设立县域医学影像信息中心，支持数据采集、存储与管理、影像处理和报告生成、数据安全等全流程管理；实行二级分层存储架构，核心数据永久保存期限不低于 15 年
安全要求	危急值管理（分类管理、明确项目清单、限时报告流程）、数据安全（等保三级、权限分级、双人审批）
管理要求	制度建设、质量控制与管理（每季度通报质量控制数据、每半年考核）、联动机制（全部乡镇卫生院接入） (来源) (来源)

该标准在质量控制方面的规定尤为系统：要求牵头医院建立医学影像质量控制团队，制定涵盖检查全流程的质量控制标准和应急预案；质量控制团队应定期召开质量控制分析会议，针对存在的问题制定改进措施，并在紧密型县域医共体范围内通报质量控制结果，形成闭环管理机制 [\(来源\)](#)。标准还明确了报告时限管理、危急值分级管理、患者安全管理等具体要求，并规定”牵头医院宜每季度对成员单位通报质量控制数据，至少每半年一次对成员单位的工作人员进行考核，定期开展质量抽查，按工作量和 work 质量实行绩效管理” [\(来源\)](#)。

在数据安全方面，标准要求“实施等保三级安全保护标准，应符合 GB/T 22239 标准要求”，数据审计日志保存时间不低于 180 天 [\(来源\)](#)。这些安全规范对医学检验中心同样具有适用性，尤其是在患者隐私保护、检验数据完整性和可追溯性方面。

1.2.2 《紧密型县域医共体心电诊断中心设置标准》（WS/T 892—2026） 发布机构：国家卫生健康委，与影像中心标准同期发布（2026 年 3 月 17 日），同步施行（2026 年 9 月 1 日）[\(来源\)](#) [\(来源\)](#) [\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。

该标准与医学影像中心标准共同构成了县域医共体资源共享中心设置标准体系，标准编号为 WS/T 892—2026。该标准由江苏省东台市卫生健康委员会参与起草 [\(来源\)](#)，体现了”国家队 + 地方实践”的协作模式，确保了标准的科学性和可操作性。

该标准在服务层级架构设计方面具有创新意义，明确了三级服务架构：

层级	机构类型	核心职能
牵头医院	县级医院	提供区域 7×24 小时心电诊断、结果反馈、危急值报告、疑难病例会诊（含远程会诊）服务、技术培训与业务指导
乡镇卫生院/社区卫生服务中心	基层枢纽	负责本院及所辖村卫生室、社区卫生服务站心电诊断，开展质量控制、技术培训与评价，疑难复杂心电图及时上传至心电诊断中心

Table 4 – continued

层级	机构类型	核心职能
村卫生室/社区卫生服务站	基层终端	提供心电图检查、心电监护基本操作、上传图形、反馈检查结果等服务

这种“中心—枢纽—终端”的三级架构模式，与医学检验中心所需的”基层采样、中心检测”服务模式具有高度的结构相似性，为其网络构建提供了直接参考。

标准在**检查项目分级管理**方面进行了细致设计，规定了 **10 类检查项目**及其实施机构要求 [\(来源\)](#) [\(来源\)](#)：

项目类别	实施机构要求	人员资质要求
常规心电图	三级均可	经培训合格
动态心电图	牵头医院、乡镇卫生院	心电学/心内科中级及以上职称
动态血压	三级均可	经培训合格
长时程遥测心电监护	牵头医院、乡镇卫生院	心电学/心内科中级及以上职称
远程心电会诊	牵头医院	心电学/心内科副高及以上职称
平板运动试验	牵头医院	动态心电图诊断经验 5 年以上、中级职称及以上
心肺运动试验	牵头医院	心内科/呼吸科/康复科副高及以上职称
直立倾斜试验	牵头医院	心内科副高及以上职称
肢体动脉测量	三级均可	经培训合格
无创血流动力学监测	牵头医院、乡镇卫生院	重症监护或心内科中级及以上职称

这种**分级分类的项目管理模式**对医学检验中心具有重要参考价值——不同检验项目可按技术难度、风险程度、设备要求等因素进行分级，分别明确实施机构资质和人员能力要求，既保证了医疗安全，又实现了资源的合理配置。

标准在**危急值管理**方面同样强化了全流程追踪：开展心电诊断危险分级管理，分为**危急、预警、普通**三级，依据不同等级实施对应处理流程；发现危急值时，应立即电话通知申请医师并指导紧急处理；常规心电图应在 **30 分钟内**出具报告，动态心电图一般应在 **24 小时内**出具报告；患者救助完成后，第一时间记录处理结果；在报告危急值 **24 小时**后对患者进行二次回访，**72 小时**后进行第三次回访 [\(来源\)](#)。这种分时段、全流程的危急值追踪管理机制，对于医学检验中心建立检验危急值管理制度具有直接借鉴意义。

标准还前瞻性地提出了**人工智能应用要求**：“支持集成并应用经认证的辅助诊断工具，对存储的心电数据进行自动分析和诊断，辅助医生快速识别心电图中的异常波形和特征，实现心电危急值预警、报告等功能” [\(来源\)](#)。这一要求与医学检验领域正在快速发展的 AI 辅助审核、智能质控等技术创新方向高度契合。

重要说明：截至 2026 年 5 月 12 日，国家层面已正式发布医学影像中心和心电诊断中心两项专项设置标准，但《**紧密型县域医共体医学检验中心设置标准**》专项标准尚未正式发布。然而，从已发布两项标准的结构一致性和政策推进节奏来看，医学检验中心设置标准的制定工作极有可能已纳入国家卫生健康委的工作计划。2026 年 4 月，国家卫生健康委已明确表示将“支持县域加紧建设影像、心电、检验等资源共享中心，规范建设和服务标准” [\(来源\)](#)。各地方在建设医学检验中心时，应充分参照影像中心和心电诊断中心的设置标准框架，结合《信息化功能指引》的技术要求，以及临床检验专业的特殊规范，进行前瞻性规划和建设。

1.3 国家检验医学中心设置标准（上位参考）

1.3.1 《国家检验医学中心设置标准》 发布机构：国家卫生健康委办公厅（国卫办医函〔2022〕370 号），2022 年 10 月 8 日印发 [\(来源\)](#) [\(来源\)](#) [\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。

该标准虽然针对**国家检验医学中心**这一更高层级的机构设置，而非**县域医共体医学检验中心**，但其在功能定位、服务能力、质量安全等方面的要求框架，为**县域医共体医学检验中心**的建设提供了重要的**上位参照**。

在**功能定位**方面，标准明确**国家检验医学中心**应”依托检验学科特色突出的**三级甲等综合医院**，在全国检验医学领域处于引领地位，并具有较好的国际影响力”**(来源)**。具体功能包括：临床检验服务、疑难危重病例会诊、新技术新项目开展、质量控制与指导、人才培养、科学研究等。在**县域医共体**场景下，医学检验中心的功能定位可相应“**下沉**”和”**适配**”为：面向**县域内各成员单位的常规检验服务、疑难检验项目的集中检测、基层检验质量控制与技术指导、检验人员培训、适宜技术推广**等。

在**基本条件**方面，标准设定了严格的准入门槛：

指标类别	具体要求
机构依托	三级甲等综合医院，检验医学科通过 ISO 15189 医学实验室认可
学科建设	获得国家 临床重点专科 建设项目；为 博士学位授权点
临床科室协同	至少 10 个 与检验医学密切相关的临床科室获得国家 临床重点专科 建设项目
检验项目覆盖	临床常规开展检验项目数 800 项
检测工作量	年总检测工作量 2500 万项次

这些指标远高于**县域层面**的实际条件，但其核心要素——**ISO 15189 认可、质量控制体系建设、检验项目覆盖度、检测工作量规模**——可作为**县域医共体医学检验中心**能力建设的参考方向。

在**技术平台**方面，标准要求具备**流式平台**（检测项目 50 项）、**质谱平台**（临床检测项目 50 项）、**高通量基因测序平台**等先进检测能力**(来源)**。这为**县域医共体医学检验中心**根据自身服务定位和区域疾病谱特点，**选择性配置特色技术平台**提供了方向指引。

在**人员队伍**方面，标准强调”具有稳定的检验医师队伍，总人数不少于 **5 人**”**(来源)**，凸显了检验医师在结果解读、临床沟通、质量控制中的关键作用。这一要求对**县域医学检验中心**的人员配置同样具有参考价值——虽然数量要求可适当降低，但检验医师的岗位设置和能力培养不可忽视。

1.4 临床检验质量控制标准

1.4.1 《临床检验专业医疗质量控制指标（2025 年版）》 发布机构：国家卫生健康委**(来源)**。

该文件为**县域医共体医学检验中心**的质量管理提供了**统一的质量控制指标体系和评价标准**，是确保检验结果准确性和可比性的基础性文件。指标体系涵盖**检验前、检验中、检验后全过程**的关键质量指标：

阶段	典型指标	管理要点
检验前	标本采合格率、标本转运及时率、标本拒收率	规范采样操作、保障冷链物流、建立核收标准
检验中	室内质控开展率、室内质控变异系数、室间质评参加率、室间质评合格率	每日质控运行、定期质评参与、失控及时处理
检验后	检验报告及时率、危急值通报率、检验结果互认率	限时报告发布、危急值闭环管理、推动结果互认

在**县域医共体**框架下，该指标体系的应用具有特殊意义。由于**医共体**成员单位众多、能力水平参差不齐，建立**统一的质量控制标准和评价指标**尤为必要。医学检验中心作为**县域内**的质量管理中心，需要承担对各成员单位检验质量的**监督、指导、评价职能**，而这一职能的履行离不开**标准化的质量控制指标体系**。2025 年版的更新发布，反映了国家层面对检验质量管理的持续重视和技术标准的与时俱进。

该指标体系与《紧密型县域医共体信息化功能指引》中要求的“**质控管理**”功能模块形成呼应，为信息化系统的质控功能设计提供了指标依据。通过信息化手段实现质量控制数据的**自动采集、实时监测、智能预警**，是提升县域医共体检验质量管理效率和水平的重要途径。

2. 省级及地区层面实施细则与地方实践

2.1 河南省

2.1.1 《河南省推进紧密型县域医共体建设相关措施》 发布机构：河南省卫生健康委（豫政办〔2025〕23号）[\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。

河南省作为国家紧密型县域医共体建设的重要先行省份，其 2025 年出台的若干措施具有鲜明的政策创新性和实践指导性。文件明确提出：“**支持医共体根据成员单位能力基础，统筹建立县域内医学影像、医学检验、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心**”，以及肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务中心，胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救中心，“**提高资源配置和使用效率**”[\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。

河南省的政策特色体现在多个维度：**统一标准体系**——将基层医疗质量和临床路径管理纳入医共体医疗质量管理与控制体系，统一医共体内规章制度和技术规范、人员培训、质量控制等标准；**用药衔接**——畅通基层医疗卫生机构与县级医院用药衔接，实现用药目录统一、采购配送统一、基本药物使用比例统一、处方自由流动；**中心药房**——鼓励依托医共体建设县域中心药房，建立短缺药品登记配送制度，解决下转患者和门诊慢性病患者用药问题；**集中审方**——建立集中审方制度，推进安全合理用药[\(来源\)](#)。

河南省的实践基础深厚。据 2021 年数据显示，该省已有 **36 个县（市）建成县域检验中心**，59 个县（市）建成县域影像中心，68 个县（市）建成县域心电中心[\(来源\)](#)。这一建设进度为 2025 年政策的全面升级奠定了坚实的设施基础。河南省还明确提出“**13710**”工作机制，强化医共体建设的推进力度和落实效率，确保政策目标按期实现。

2.1.2 河南省信息化建设专项规划 发布机构：河南省卫生健康委员会[\(来源\)](#)。

2020 年，河南省即已发布紧密型县域医共体信息化建设蓝图，明确提出以实现互联互通、信息共用共享、远程医疗覆盖和提升智慧管理服务水平为目标，全面加强紧密型县域医共体信息化建设。具体措施包括：按照全省统一的数据资源目录，建设统一标准的区域平台数据中心；依托医疗专网实现县域远程诊疗全覆盖；**推进标准化区域医学检验、影像诊断、病理诊断、消毒供应、心电诊断等共享中心建设，推进检验检查结果共享互认**[\(来源\)](#)。这一早期规划为后续国家层面《信息化功能指引》的制定提供了重要的地方经验支撑。

2.2 陕西省

2.2.1 安康市紧密型县域医共体建设实践 发布机构：陕西省卫生健康委[\(来源\)](#)。

陕西省安康市的实践是西部地区紧密型县域医共体建设的典型案例，其医学检验等资源共享中心的建设经验具有较强的地方特色和推广价值。安康市在推进医共体建设过程中，形成了“**四统**”管理模式——组织架构统建、资金打包统合、医疗服务统提、内部运行统管。

在**组织架构统建**方面，医共体总院负责整体工作，各分院设执行院长负责日常工作，实行总院副职和分院执行院长双向任职。这一制度设计赋予了总院对各分院执行院长、院级副职人选选拔任用的建议权，实现了人员力量的统筹调配，形成“**一名独立法人、一套领导班子、一个组织架构**”的高度统一的治理体系。对于医学检验中心而言，这种高度统一的组织架构有利于打破机构壁垒，实现检验人员的统一调配和集中管理。

在**医疗服务统提**方面，安康市推动 10 个县级医院实现对口帮扶“双重”覆盖，派驻专家到县“传帮带”。更为重要的是，医共体总院建立了**影像、心电、检验、药事管理等资源共享中心**，形成了较为完整的资源共享体系。其中，**检验中心覆盖 28 个乡镇卫生院**[\(来源\)](#)，虽然覆盖率相较于影像中心（138 个）和心电中心（124 个）仍有较大差距，但已初步形成服务网

络。这一数据差异反映出医学检验中心建设的技术门槛和运营复杂度相对较高，推进速度相对较慢，需要更大的政策支持和资源投入。

在**内部运行统管**方面，安康市实施了“八统一”管理——行政后勤、人员队伍、财务审计、绩效分配、医疗业务、医保政策资金、药械业务、信息系统建设。总院组建质量控制团队，对镇级分院实行”全覆盖”医疗质量管理（来源）。这一管理模式对于医学检验中心的质量同质化至关重要——通过统一的质量控制标准和全覆盖的质量督查，能够有效缩小总院与分院、分院与分院之间的检验质量差距。

安康市将城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金**打包预付**给总院统管统用，按”两个允许”用于提高医务人员绩效待遇，同时将公共卫生资金统一拨付至医共体总院。这种**资金打包统合**的机制，为医学检验中心的可持续运营提供了财务保障，也激励总院通过提升检验服务效率和质量来优化资源配置。

2.3 广东省

2.3.1 《广东省紧密型县域医疗卫生共同体高质量发展行动方案（2022—2025 年）》 发布机构：广东省人民政府办公厅（粤办函〔2022〕245 号）（来源）（来源）（来源）（来源）。

广东省作为经济发达省份，其行动方案在检验检查互认方面设定了明确的时间表和路线图。方案明确提出：“**加快推进县域医共体检验中心、影像中心、心电中心、病理中心等资源共享中心在县域内全域运行**”，提高医疗资源配置和使用效率；加强对县域医共体各分院检查检验项目的质量控制和培训；“**到 2023 年，基本实现县域医共体各分院之间的检查检验结果互认共享，形成‘基层检查 + 县级诊断’格局**”（来源）（来源）。

“**基层检查 + 县级诊断**”格局的形成，实质上是对医学检验中心功能定位的明确界定——基层医疗机构承担样本采集、常规检验等基础功能，县级医院检验中心承担复杂检验、质量控制、结果审核等核心功能。这种功能分工既发挥了基层机构的网络覆盖优势，又利用了县级医院的技术能力优势，实现了资源的最优配置。

广东省的方案还特别强调”**高质量发展**”，意味着医学检验中心的建设不仅要解决”有没有”的问题，更要追求”好不好”的发展质量，在服务能力、技术水平、管理效率、患者体验等方面实现全面提升。方案提及了**上海松江区域临床检验中心和西安区域医学检验中心**（来源）作为参考案例，表明广东省在政策制定过程中注重借鉴国内外先进经验。

广东省的实践进展显著。截至 2025 年底，粤东粤西粤北及江门、惠州、肇庆共 **65 个县（市、区）已建成紧密型县域医共体**，统一建设医学检验、影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心（来源）。2025 年，广东省进一步发布医疗卫生强基工程预通知，明确提出支持建设县域医学检验等资源共享中心，逐步补齐业务用房、配齐医疗设备和信息化系统，大力推进”**分布式检查、集中式诊断**”，并加快人工智能技术推广应用（来源）。

2.4 江苏省

2.4.1 高邮市”县域 + 区域”医共体建设实践 高邮市的实践是江苏省县域医共体建设的创新探索，其核心特征在于打造”**县域 + 区域**”医共体模式，实行”**基层检查、上级诊断**”的服务机制（来源）。这一模式的关键创新在于突破了传统县域行政边界，构建更大范围的医疗资源共享网络，为医学检验中心的规模化、集约化运营提供了新思路。

高邮市通过这一模式推动服务同质化，取得了显著成效：**基层诊疗量占比达 69.37%，县域内就诊率达到 94%**（来源）。这两个数据指标充分说明，有效的检验等资源共享机制能够显著提升基层医疗服务能力，增强患者对基层医疗机构的信任度，从而促进分级诊疗目标的实现。高比例的县域内就诊率意味着患者留在县域内接受诊疗服务，减少了向上级医院的外流，既方便了患者就医，又节约了医保资金，实现了多方共赢。

高邮市的经验对于医学检验中心建设的启示在于：检验资源的整合共享需要与影像、心电等其他资源共享**协同推进**，形成综合性的资源共享服务体系；信息化建设是实现”**基层检查、上级诊断**”的**技术基础**，需要投入足够的资源建设高速、稳定、安全的信息网络；**服务同质化**是赢得患者信任的关键，需要通过统一的质量标准、规范的操作流程、及时的结果反馈来保证检验服务的一致性和可靠性。

2.4.2 江苏省东台市”十大中心”建设实践 江苏省东台市是国家层面推广的紧密型县域医共体建设典型案例，其”**十大中心**”模式被纳入《紧密型县域医共体信息化功能指引》的典型案例汇编（来源）（来源）。东台市的临床检验中心建设具有

标杆意义：

建设指标	具体数据
覆盖范围	市、区域中心、镇、村四级全覆盖
服务模式	配备设备，标本流转规范，结果联网共享
服务成效	累计服务 64 万人次 ，减少群众交通费、误工费
带动效应	大型设备检查阳性率从 2021 年的 75.23% 提高到 2023 年的 95.36% ，节约群众看病就医费用 超亿元

东台市临床检验中心的功能定位包括：依托县人民医院等机构，为基层提供医学检验和病理诊断服务，实现**同质化检验诊断结果**，承担**质量控制、会诊服务**等职能。其成功经验在于将检验中心纳入整体”十大中心”架构（远程会诊中心、临床检验中心、网络心电中心、区域影像中心、集中审方中心、智慧急救中心、消毒供应中心、健康随访中心、医护调度中心），形成**协同效应**，而非孤立建设（来源）（来源）。

2.5 安徽省

2.5.1 濉溪县全民健康信息平台建设实践 濉溪县的实践突出了**信息化平台建设**在医学检验等资源共享中的基础性作用。该县依托全民健康信息平台建立区域资源共享中心，实现检查检验结果互认和健康档案调阅，近两年累计提供**远程服务 9.4 万人次**，县域内住院率达到 **86.03%**（来源）。

9.4 万人次的远程服务量是一个相当可观的数字，反映出县域内对远程检验诊断服务的旺盛需求。这一数据也间接说明，基层医疗机构的检验能力存在较大缺口，需要依托县级医院的检验资源来满足临床需求。86.03% 的县域内住院率同样印证了资源共享机制的有效性——当患者能够在县域内获得高质量的检验诊断服务时，其住院诊疗意愿也会相应提高，减少了不必要的外转就医。

濉溪县的经验特别强调了”**依托全民健康信息平台**”这一技术路径，与《紧密型县域医共体信息化功能指引》的要求高度契合。这表明，医学检验中心的建设不能仅关注硬件设备和人员配置，必须将**信息化建设**置于同等重要的位置，通过信息平台实现检验数据的实时传输、结果的即时查阅、质量的在线监控、资源的智能调度。

安徽省作为国家紧密型县域医共体建设的重要发源地之一，早在 2014 年即开始探索县域医共体模式。2016 年 3 月，**天长市被确定为全国县级公立医院综合改革示范县**，探索出具有中国特色的农村分级诊疗服务模式（来源）。在省级政策层面，《关于加强绩效考核和监测评价全面推动紧密型县域医疗卫生共同体高质量发展的通知》明确要求”建立县域内开放共享的影像、心电、病理诊断、医学检验、消毒供应和医疗废物垃圾处理等中心，全面推进县域内各医疗卫生机构信息系统融合”，并提出”力争到 2021 年底，各地要实现县域内医疗卫生机构之间信息互联互通、检查资料和信息实时共享，检验、诊断结果互认”（来源）。

2.5.2 六安市叶集区区域医共体医学检验中心建设方案 发布机构：六安市叶集区人民医院（总院）（来源）。

安徽省六安市叶集区的实践是当前可查证的最为具体的县域医共体医学检验中心建设案例之一。2025 年 11 月，六安市叶集区人民医院发布《区域医共体医学检验中心建设方案征集公告》，明确该项目”区域医学检验中心为六安市叶集区人民医院（总院）“，中心覆盖 **6 家公立医疗机构**：姚李镇卫生院、洪集镇卫生院、孙岗乡卫生院、平岗街道社区卫生服务中心、三元镇卫生院、史河街道社区卫生服务中心（来源）。

该项目建设内容具有系统性和前瞻性：

建设模块	具体内容
基础设施	完成院区医学检验中心的设计规划与改造装修
功能配置	实验室基本功能配置、设备配置
特色平台	精准实验室建设

Table 9 – continued

建设模块	具体内容
流程优化	检验流程优化设计
质量认证	ISO 15189 质量认证辅导
支撑平台	区域标准化检验样本物流平台、区域检验信息化交互平台、检验质控平台

通过引进新项目、新技术，全面提升科室医学检验能级，同时建设”区域标准化检验样本物流平台、区域检验信息化交互平台、检验质控平台等，实现区域内检验资源共享，检验信息互联互通，检验结果互认，为分级诊疗、双向转诊提供有效支撑”[\(来源\)](#)。

这一实践案例的突出特点在于：一是明确将 **ISO 15189 质量认证**纳入建设目标，体现了与国际标准接轨的质量追求；二是构建了”**样本物流—信息交互—质量控制**”三位一体的支撑平台体系；三是实现了从设计规划到运营认证的全流程覆盖。该案例为其他地区制定医学检验中心设置标准提供了具体的参照模板。

叶集区人民医院作为叶集区紧密型医共体唯一牵头单位，下辖 6 家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、2 家民营医院、76 家村卫生室（卫生服务站），其医学检验中心的建设规模和服务半径具有典型县域特征 [\(来源\)](#)。

2.6 福建省

2.6.1 三明市紧密型县域医共体信息化建设应用 三明市作为全国医改的标杆城市，其县域医共体建设经验具有全国性的示范意义。三明市将县、乡、村三级医疗机构整合为“一家人”，实行**人、财、物一体化管理**，实现医疗资源和信息共享，形成**管理、责任、服务、利益的共同体** [\(来源\)](#)。

“一家人”的治理理念是三明模式的核心创新，其本质是通过体制机制改革消除医疗机构间的利益分割，建立**利益共享、责任共担**的共同体关系。对于医学检验中心而言，这意味着检验资源不再是某一机构的”私有财产”，而是整个医共体的”公共资产”，可以打破机构界限进行统一调配和优化配置。**人、财、物的一体化管理**，使得检验人员的统一招聘、培训、调配，检验设备的统一采购、配置、维护，检验收入的统一核算、分配、使用成为可能，从根本上解决了资源共享的体制障碍。

三明市的信息化建设同样走在全国前列，通过建立区域信息平台，实现了检验等医疗数据的互联互通和共享利用。这为医学检验中心的远程服务、结果互认、质量监控提供了技术支撑，也为国家层面制定信息化功能指引提供了实践验证。

福建省在省级层面进一步系统部署。2024 年 6 月，福建省卫生健康委员会等九部门印发《关于进一步推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的实施方案》，明确提出”完善县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应、远程会诊等**六大资源共享中心**”[\(来源\)](#) [\(来源\)](#)，将国家层面的五大中心扩展为六大中心，增加了远程会诊中心。方案设定了明确的阶段性目标：**到 2025 年底**，各县域医共体全部达到国家紧密型评判标准；**到 2027 年底**，全省各县域医共体管理体制运行机制进一步巩固，县乡村三级协同更加高效 [\(来源\)](#)。

2.7 山西省

2.7.1 某县医疗集团信息化建设案例 山西省作为 2019 年确定的 **3 个紧密型县域医共体建设试点省份**之一，其探索实践起步较早，积累了丰富经验。某县医疗集团的案例展示了信息化赋能下医学检验中心建设的具体路径 [\(来源\)](#)。

该医疗集团建立了”**县医疗集团—县医院/乡镇分院**”**线上型事业部型组织结构**，依托”县乡村一体化管理平台—四大管理中心”进行管理。在资源共享方面，设立了**区域影像中心、区域检验中心、远程心电中心、远程会诊中心**，形成了较为完整的资源共享中心体系 [\(来源\)](#)。这一组织架构的创新之处在于引入了”**事业部制**”这一企业管理模式，将检验中心等资源共享部门作为相对独立的业务单元进行运营管理，既保持了集团的统一协调，又赋予了运营管理的灵活性。

在业务分工方面，该案例明确了县医院与乡镇分院的功能定位：**乡镇分院分工定位于任务单一、技术相对简单的临床接诊信息提取**，如体液抽取等；县医院负责**病情诊断、治疗方案出具**等技术难度和质量要求高的工作 [\(来源\)](#)。这种”**分布式采集、集中式检测**”的模式，既扩大了检验服务的覆盖范围，又保证了检验质量的可控性。

该案例还揭示了信息化建设对于流程优化的关键作用。通过一体化管理平台，医疗集团实现了对乡镇分院的人员、财务、药品资源的精准调配，并由绩效管理中心对各单位资源使用效率进行业绩评估。区域检验中心的信息系统需要与这一平台深度对接，实现检验申请、样本追踪、结果反馈、费用结算等业务流程的数字化贯通。

该案例还展示了信息化平台的性能要求：“系统能支持 **400 个以上并发用户** 的访问，每项业务处理时间在 **5 秒内** 完成，支持 **百万级数据规模** 的快速存储和查询”[\(来源\)](#)。这些技术指标为医学检验中心信息系统的建设提供了具体参数。

2.8 新疆维吾尔自治区

2.8.1 《关于推进自治区医疗机构间医学检查检验结果互认试点工作的通知（征求意见稿）》 发布机构：新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 [\(来源\)](#)。

新疆维吾尔自治区的这份文件虽然处于征求意见稿阶段，但其内容反映了边疆民族地区在推进检验结果互认方面的政策探索，具有特殊的地域代表性。文件明确“**集团互认**”原则：**紧密型城市医疗集团、医联体、县域医疗共同体内医疗机构之间互认清单内的检验、影像、超声检查检验结果可互相认可** [\(来源\)](#)。这一规定将县域医共体内部的检验结果互认置于优先推进的位置，因为医共体内部的管理统一性为互认提供了制度基础，风险可控性相对较高。

互认清单制度的引入，体现了审慎推进的原则——并非所有检验项目一律互认，而是根据项目特点、临床需求、技术条件等因素制定互认清单，对于稳定性差、时效性强的项目可能暂不纳入互认范围。

在技术保障方面，文件提出了两项重要措施：一是**依托自治区全民健康信息平台建设检查检验互认共享平台**，扩展数据采集范围和标准，完善检查检验互认功能模块，接入各级区域全民健康（或县域医共体）信息平台实现检查检验结果逐级接入互认；二是对互认的检查检验结果电子报告单制定**唯一的溯源码**，确保检查检验结果的真实性 [\(来源\)](#)。

溯源码制度的建立，是保障检验结果互认可信性的重要技术创新，对于防止检验报告伪造、篡改，确保互认结果的可靠性具有重要意义。这一制度设计可为其他地区医学检验中心的信息化建设提供借鉴，也为国家层面制定相关标准提供了地方经验。

文件还规定了明确的时间节点：试点地（州、市）需在 **2024 年 9 月 30 日前**完成辖区内二级及以上医疗卫生机构检验检查数据的采集汇聚和调阅共享功能，并确保与自治区全民健康信息平台对接 [\(来源\)](#)。

3. 地方创新实践模式参考

3.1 上海市松江区区域临床检验中心模式

上海市松江区的区域临床检验中心建设是国内较早的探索实践，其经验对于县域医共体医学检验中心的建设具有重要借鉴价值 [\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。

该模式的核心特征在于实现了辖区内 **18 家**社区卫生机构检验标本的**集中检测**。具体运作机制为：**除三大常规（血常规、尿常规、大便常规）外，其他检验标本统一通过民营公司专业化物流送往区域性临床检验中心检测**。这一“**常规分散、非常规集中**”的策略设计颇具巧思——三大常规是基层医疗机构开展最频繁、技术最成熟的检验项目，保留在基层检测既满足了即时性需求，又避免了不必要的标本转运；而其他项目因设备要求高、检测频率低、质量控制难等原因，集中至区域中心检测能够实现规模效益和质量保证。

在**功能设置**方面，松江区区域性临床检验中心设置了 **8 个亚专业小组**：急诊室、临检室、生化免疫室、细胞室、PCR 室、细菌室、结核室、感染性疾病检验室 [\(来源\)](#) [\(来源\)](#)，形成了较为完整的检验学科体系。这种亚专业分组模式，既保证了各专业领域的技术深度和质量水平，又通过区域中心的规模效应实现了人力资源和设备资源的优化配置。对于县域医共体医学检验中心而言，可根据县域人口规模、疾病谱特点、成员机构需求等因素，参照这一模式进行亚专业的选择性设置，不必追求“大而全”，而应注重“专而精”。

松江模式的成功要素还包括：**专业化物流公司的引入**，解决了标本转运的时效性和安全性问题；**与区域性临床检验中心实施合并的乐都医院检验科**，为区域中心提供了技术骨干和管理经验；**通过卫健委平台实现的信息互联互通**，为检验结果的及时反馈和共享利用提供了技术支撑。这些要素的综合作用，使得区域临床检验中心模式得以顺畅运行。

3.2 西安区域医学检验中心模式

西安区域医学检验中心在体制机制上进行了更大胆的创新，采用 **PPP 模式**，即“政府授权 + 社会资本建设 + 公司化运营”[\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。该中心**总投资 10 亿元**，将通过建设三级检验网络，实现基层公共卫生服务水平和基层疫情防控能力的大幅提升。

该模式的核心架构是“**1+15+450**”的三级检验网络：

层级	数量	功能定位	建设方式
核心实验室	1 个	按照国际标准建设，可开展 3000 多项 医学检验项目	在西咸新区沣东新城新建
二级中心实验室	15 个	承担区域内常规检验项目的集中检测和质量控制	将西安市卫健委下属 15 家医院检验科合作升级
社区网点实验室	450 个	提供样本采集、简单检测、结果反馈等基础服务	将 450 家政府社区卫生服务中心或乡镇卫生院检验科扩建

这种**三级网络架构**与紧密型县域医共体的”**县级医院—乡镇卫生院—村卫生室**”三级服务体系具有结构相似性，其设计理念和运营机制可为县域医共体医学检验中心的网络布局提供参考。**核心实验室**承担**高端、复杂、疑难**检验项目的检测，以及新技术新项目的研发应用；**二级中心实验室**承担区域内常规检验项目的集中检测和质量控制；**社区网点实验室**承担样本采集、简单检测、结果反馈等基础服务。这种功能分层、资源共享的网络化架构，既保证了检验服务的全面覆盖，又实现了优质资源的集约利用。

PPP 模式的引入，有效解决了政府投入不足的问题，社会资本的参与带来了先进的管理理念、技术手段和市场机制。但需要注意的是，PPP 模式在县域层面的适用性可能受到市场规模、回报机制、监管能力等因素的制约，需要结合当地实际进行审慎评估和制度设计。对于县域医共体医学检验中心建设，PPP 模式可作为备选方案，但需要在标准中明确准入条件、监管要求和退出机制。

3.3 河北省医共体建设实践

河北省在紧密型县域医共体建设中，将医学检验中心等资源共享中心的建设作为重点任务，推进县域内检查检验结果互认[\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。河北省的政策特色在于构建了**多层级互认体系**，并通过**室间比对**等技术手段确保检验质量。

河北省的实施意见明确规定：**2025 年底前，共享中心服务覆盖所有成员单位** [\(来源\)](#) [\(来源\)](#)。在互认机制方面，河北省建立了**三级互认体系**：

互认层级	适用条件	标识方式
内部互认	城市医疗集团和县域医共体由牵头单位组织开展质量评价（检验项目需通过牵头单位组织的室间比对），评价合格后内部开展互认	—
全省互认	二级以上医疗机构需根据自身开设情况应认尽认；参加室间质评通过后可在全省范围内互认	“”
京津冀互认	参加京津冀医学检查检验结果互认的医疗机构	影像” —JJJHR”、检验” ”

这种分级互认体系既保证了互认的安全性（通过质量评价和室间比对筛选合格机构），又实现了互认的渐进扩展（从集团内部到全省再到京津冀区域），为检验结果的区域流通和患者就医便利化提供了制度保障。其对检验项目的**室间比对要求**，也为县域医共体医学检验中心的质量控制提供了可操作的技术路径。

4. 标准体系建设现状与展望

4.1 现行标准体系特点

4.1.1 国家层面标准体系现状 当前国家层面关于紧密型县域医共体医学检验中心的标准体系呈现”政策引导完善、专项标准缺位、相关标准支撑”的特点，可概括为”两标准、一指引、多参考”的格局：

文件类型	文件名称	发布状态	核心作用
专项设置标准	WS/T 891—2026《紧密型县域医共体医学影像中心设置标准》	已发布，2026 年 9 月施行	提供标准框架参照
专项设置标准	WS/T 892—2026《紧密型县域医共体心电图诊断中心设置标准》	已发布，2026 年 9 月施行	提供标准框架参照
信息化功能指引	《紧密型县域医共体信息化功能指引》（国卫办规划函〔2025〕63 号）	已发布，2025 年 3 月	明确检验中心功能架构和技术要求
纲领性政策文件	《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发〔2023〕41 号）	已发布，2023 年 12 月	确立建设目标和基本原则
上位参考标准	《国家检验医学中心设置标准》（国卫办医函〔2022〕370 号）	已发布，2022 年 10 月	提供功能定位和能力框架参照
质量控制标准	《临床检验专业医疗质量控制指标（2025 年版）》	已发布，2025 年	提供质量管理指标体系和评价标准
信息化建设标准	WS/T 482-2016、WS/T 483-2016、WS/T 500-2016 等系列标准	已发布	规范信息交换和数据共享
国际标准	ISO 15189、IHE、HL7	现行有效	实验室管理和信息互操作国际规范

专项标准缺位是当前最突出的短板。与医学影像中心设置标准、心电图诊断中心设置标准已正式发布形成对比，医学检验中心专项设置标准尚未出台（来源）（来源）。这一缺位状态导致各地在建设医学检验中心时缺乏统一的技术规范和评价标准，可能出现建设标准不一、服务质量参差不齐的问题。

分析其原因，可能包括：检验项目种类繁多、方法学复杂多样，标准制定技术难度大；不同地区、不同层级医疗机构的检验能力差距较大，标准参数难以统一；检验质量控制涉及因素众多，标准制定需要充分的临床验证和专家共识；生物安全风险类型多样，实验室安全标准需要综合考量多种病原微生物防护要求。

然而，标准发布的信号已经释放。2026 年 3 月，国家卫生健康委一次性发布 3 项推荐性卫生行业标准（影像中心、心电图诊断中心、家庭病床康复服务标准）（来源）（来源），标志着县域医共体资源共享中心标准化建设进入快车道。2026 年 4 月，国家卫生健康委进一步明确将“支持县域加紧建设影像、心电、检验等资源共享中心，规范建设和服务标准”作为重点工作方向（来源）。按照”成熟一个、发布一个”的渐进式策略，医学检验中心专项设置标准的制定和发布可期。

从已发布的影像中心和心电图诊断中心标准来看，国家卫生健康委已建立了“七维度”标准框架（基本要求、场所要求、设施设备要求、人员要求、信息化要求、安全要求、管理要求）（来源），医学检验中心设置标准 likely 将采用类似框架，但会根

据检验医学特点增加“检验项目设置要求”“样本采集与运输要求”“室内质量控制与室间质量评价要求”等专业模块。

4.1.2 地方层面标准体系特点 地方层面的标准体系建设呈现出“实施方案为主、地方标准为辅、实践探索先行”的特点：

特征维度	具体表现
文件形式	多以实施方案、行动方案、指导意见、若干措施等政策性文件出现，专门的”设置标准”较少
内容侧重	侧重结果互认、资源共享、同质化服务等目标导向，对具体设施、人员、技术参数规定相对原则
标准参照	具体设置标准多参照国家临床检验中心设置标准及 ISO 15189 实验室认可标准，缺乏针对县域医共体特殊场景的细化规定
时间节点	多数省份设定 2025—2026 年为资源共享中心建设的关键节点，与国家推进节奏基本同步
创新探索	各地积极开展实践探索，形成多种建设模式，为国家标准制定提供案例素材和经验验证

4.2 关键标准依据汇总

4.2.1 信息化建设标准体系 医学检验中心信息化建设需遵循多层次标准规范，形成完整的标准矩阵：

标准层级	标准编号/名称	核心作用
国家卫生健康行业标准	WS/T 482-2016《卫生信息共享文档编制规范》	规范检验报告等医疗文档的标准化格式 (来源) (来源)
国家卫生健康行业标准	WS/T 483-2016《健康档案共享文档规范》	实现检验结果向居民健康档案的自动归集 (来源) (来源)
国家卫生健康行业标准	WS/T 500-2016《电子病历共享文档规范》	实现检验结果在电子病历中的集成展示 (来源) (来源)
国家卫生健康行业标准	WS 538-2017《医学数字影像通信基本数据集》	为检验相关的病理图像等提供数据标准 (来源)
国际标准	ISO 15189《医学实验室——质量和能力的要求》	实验室质量管理体系建设的核心国际规范 (来源) (来源)
国际标准	IHE（医疗信息集成规范）	规范检验信息系统与其他系统的集成接口 (来源) (来源)
国际标准	HL7（卫生信息交换标准）	实现检验订单、结果等数据的跨系统交换 (来源) (来源)
信息安全标准	GB/T 22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》	等保三级安全防护要求 (来源)

上述标准共同构成了检验中心信息化建设的规范基础。其中，ISO 15189 作为国际公认的医学实验室质量管理标准，是检验中心能力建设的核心参照；IHE 和 HL7 标准确保了检验信息系统与医院信息系统、全民健康信息平台之间的互操作性；WS/T 系列国家标准规范了与国内卫生健康信息体系的对接；GB/T 22239 则保障了信息系统的安全防护水平。

4.2.2 质量控制标准体系

标准/文件名称	发布机构	核心内容	适用环节
《临床检验专业医疗质量控制指标（2025 年版）》	国家卫生健康委	检验全过程质量控制指标体系	质量评价与持续改进 (来源)
国家/省级临床检验中心室间质量评价	国家卫生健康委临床检验中心/各省级临床检验中心	实验室间结果可比性评价	外部质量保障
县域医共体统一服务质量控制标准	各地卫生健康行政部门/医共体总院	医共体内统一的质量控制标准和要求	内部质量同质化
ISO 15189《医学实验室——质量和能力的要求》	国际标准化组织（ISO）	医学实验室质量管理体系国际规范	系统性质量管理

质量控制标准体系的核心是 **2025 年版临床检验专业医疗质量控制指标**，该指标体系由国家卫生健康委发布，涵盖检验全过程的关键质量指标，为县域医共体医学检验中心建立统一的质量评价体系提供了**标准化工具**。在县域医共体的特殊背景下，质量控制指标的应用还需要考虑**多层次机构协同**的特点——标本从基层采集到中心检测的运输时间、标本在运输过程中的保存条件、基层采集标本的合格率等，都是影响检验质量的关键环节，需要纳入质量控制指标体系进行监测和管理。

4.3 医学检验中心设置标准的前瞻性框架

基于对已发布标准的分析和对政策趋势的研判，未来可能发布的《紧密型县域医共体医学检验中心设置标准》预计将涵盖以下核心模块：

模块	预期内容要点
基本要求	设置原则（依托牵头医院、原则上 1 个县域 1 个中心）、功能定位（集中检测、质量控制、技术指导、结果互认）、服务范围（明确检验项目清单）
场所要求	功能区域（样本接收与处理区、实验区、试剂储存区、办公区、生物安全区等）、环境要求（温湿度控制、生物安全等级、通风系统）
设施设备要求	分级设备配置（牵头医院配备全自动生化分析仪、免疫分析仪、血液分析仪、凝血分析仪、微生物培养鉴定系统等；成员单位配备样本采集和初筛设备）、冷链物流设备、信息化设备
人员要求	负责人资质（检验医学中级及以上职称）、检验人员配置（按工作量计算，明确各专业组最低人员数量）、样本采集人员培训要求
信息化要求	LIS 系统功能（参照功能指引 11 项模块）、与全民健康信息平台对接、检验结果互认接口、数据安全（等保三级）
安全要求	生物安全管理（参照《病原微生物实验室生物安全管理条例》）、危急值管理（明确项目清单和报告时限）、医疗废物处理、职业安全防护
管理要求	质量管理体系（室内质控、室间质评）、样本全流程追溯、报告审核制度（双审核）、绩效评价、持续改进机制
检验专业特色模块	检验项目分级设置（基础项目/常规项目/拓展项目）、样本采集与运输规范、室内质量控制与室间质量评价特殊要求

4.4 建设实施的关键建议

基于对现有政策文件和地方实践的综合分析，对县域医共体医学检验中心建设提出以下建议：

第一，标准先行，规范建设。在国家标准正式发布前，各地应积极参照《信息化功能指引》和已发布的影像中心、心电诊断中心标准，结合 ISO 15189 等国际标准，制定本地化的建设规范或指南，避免低水平重复建设和资源浪费。已发布标准的**七维度框架**（基本要求、场所要求、设施设备要求、人员要求、信息化要求、安全要求、管理要求）可作为本地化标准制定的直接模板。

第二，质量为本，互认为要。检验中心的核心价值在于提供**高质量、可互认的检验结果**。应建立健全覆盖检验前、中、后的全流程质量管理体系，特别重视样本采集规范化、冷链物流标准化、检测过程自动化、结果报告信息化等关键环节，确保检验结果的准确性和可比性。**ISO 15189 认可**应作为推荐性质量目标，激励检验中心持续改进。

第三，信息赋能，智能升级。充分利用人工智能、大数据、云计算等新技术，推进检验中心的智能化升级。包括**智能审核检验申请、智能识别异常结果、辅助诊断决策、预测性维护设备、优化检验流程**等，提高检验效率和服务质量。已发布的心电诊断中心标准对 AI 辅助诊断的明确要求（[来源](#)），预示着检验中心标准也将纳入智能化技术要求。

第四，人才下沉，能力提升。通过”县管乡用”、驻点服务、远程培训等多种方式，加强基层样本采集人员和检验技术人员的能力建设，确保检验前质量控制和基层检验服务能力的持续提升。安康市”八统一”管理中的人员队伍统一（[来源](#)）、山西省某县的事业部型组织结构（[来源](#)），均为人员管理创新提供了参考。

第五，政策协同，保障可持续。积极协调医保、财政、人事等部门，完善检验中心服务的支付保障机制，探索按人头付费、按病种付费等多元化支付方式，确保检验中心的可持续运营和发展。四川省将”基层医疗机构委托第三方开展的常规检验项目纳入医保基金支付范围”的政策创新（[来源](#)），为检验中心服务的支付保障提供了有益借鉴。